PROTOCOLLO 32

Gestione dello spostamento discale senza riduzione

Recuperare apertura e funzione nella limitazione da disco

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Spostamento discale senza riduzione	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Apertura limitata improvvisa dopo un periodo di click
- ✓ Deflessione verso il lato colpito
- ✓ Fase non acuta

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Valutazione

Conferma la limitazione e la deflessione secondo DC/TMD.

2



FASE 2

Distrazione

Distrazione caudale graduale.

3



FASE 3

Scivolamento

Scivolamento anteriore progressivo.

4



FASE 4

Esercizio

Apertura attiva assistita nel range ottenuto.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III secondo tolleranza
Tempo	3 serie da 60 secondi
Obiettivo	apertura funzionale superiore a 35 mm

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	____ / 10	Retta / Deviata
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Molti pazienti migliorano con trattamento conservativo
- ✓ Procedi con gradualità
- ✓ Collabora con l'odontoiatra

Errori da evitare

- ! Manovre di riduzione forzata
- ! Sedute troppo aggressive
- ! Promettere la scomparsa del problema

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura assistita	Aprire aiutandosi con le dita sugli incisivi inferiori	5 x 10 secondi, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'obiettivo realistico è il recupero funzionale, anche senza riposizionamento del disco.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.